

HEPATITIS AGUDA EN URGENCIAS

Cristina Sardiña González, M^a Elena Aguirre Alastuey, Joaquín Llorente García, Manuel Lorenzo López Reboiro, Adrián Argüelles Curto, Ylenia Fernández Ramírez.

INTRODUCCIÓN

La hepatitis aguda es una entidad caracterizada por inflamación aguda con necrosis del parénquima hepático, lo cual produce síntomas constitucionales variables, ictericia y elevación de las aminotransferasas.

Según la causa, las hepatitis agudas se pueden dividir en:

- **hepatitis viral:** virus hepatotropos (A, E, B, D, C). Existen otros virus como citomegalovirus, herpes, varicela zóster, Epstein-Barr, sarampión, adenovirus, fiebre amarilla...
- **hepatitis por sustancias tóxicas y fármacos:** dosis dependiente e idiosincrásica.
- **hepatitis fulminante:** como consecuencia de infecciones (viral, bacteriana, parásitos), fármacos y toxinas, isquemia, sd. Budd-Chiari, hepatitis crónica activa idiopática, enfermedad de Wilson aguda y síndromes adiposos microvesiculares (Sd. de Reye, hígado graso del embarazo).

DIAGNÓSTICO

- **Anamnesis:** exposición a tóxicos, fármacos, setas...Revisar historia clínica antigua.
- **Clínica y exploración física:** toma de constantes. Detectar existencia de ascitis, signos de encefalopatía o hepatopatía crónica. Sintomatología muy variable: malestar inespecífico, náuseas, vómitos, diarrea y febrícula, coluria, ictericia (a partir del 2º día) y hepatomegalia dolorosa. Característico de las hepatitis tóxicas la aparición de exantema y artralgias. La hepatitis fulminante cursa con signos y síntomas de encefalopatía que evolucionan y llegan al coma profundo.
- **Analítica sanguínea:** hemograma (puede existir trombopenia), coagulación y bioquímica con iones, pruebas hepáticas (GOT, GPT, AMILASA), bilirrubina, LDH, urea y amonio, gasometría arterial, lactato, tóxicos en sangre y orina, marcadores víricos y VIH. En mujeres realizar test de embarazo.
- **Hallazgos típicos:** hipoglucemia (40%), fallo renal (30-40%), hiponatremia, hipertransaminasemia (GOT x 50-60 su valor normal), hiperbilirrubinemia, trombopenia y alargamiento del tiempo de protrombina. Hipoxemia y distress respiratorio.
- **ECG**
- **Pruebas de imagen:** radiografía de tórax y abdomen. Ecografía abdominal-TAC abdominal (lesiones ocupantes de espacio, valoración venas y arterias hepáticas, ascitis). TAC craneal si deterioro neurológico (hipertensión intracraneal).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- Cama a 30º y reposo absoluto.
- Monitorización cardíaca, respiratoria y neurológica por el alto riesgo de desarrollar hepatitis fulminante.
- Oxigenoterapia a flujos altos (FiO2 50%).
- Vía venosa: administrar suero glucosado 10% (minimizar hipoglucemias).
- Sonda vesical.
- Si encefalopatía grado III-IV: SNG. Valorar intubación orotraqueal según evolución.

- Si encefalopatía grado I-II evitar sedantes de acción central.
- Ranitidina 250 mg iv.
- Vitamina K 10 mg iv.
- Tratamiento etiológico si fuera posible:
- Sospecha de hepatitis por sustancias tóxicas y fármacos: retirar la sustancia sospechosa y lavado gástrico con administración oral de carbón o colestiramina. Antídoto específico del Paracetamol: N-Acetilcisteína.

Criterios de gravedad

Hepatitis tóxica por paracetamol	otras causas
Acidosis metabólica (pH<7.3) y/o: • TP >100 seg (INR>7) + • Creatinina >3.4 mg/dL + • Encefalopatía grado III / IV	TP>100 seg (INR>7) y/o al menos 3 de los siguiente: • Edad: < 10 ó >40 años • Etiología no conocida o fármacos • TP >50 seg (INR>3.5) • Bilirrubina > 17mg/dL • Intervalo entre ictericia y encefalopatía > 7 días.

El **objetivo fundamental** es el apoyo del paciente por medio de la conservación del equilibrio hidroelectrolítico, apoyo circulatorio y respiratorio, control de hemorragias y el **control de las complicaciones**.

BIBLIOGRAFÍA

- Dienstag JL: Hepatitis viral aguda. Harrison, Principios de medicina interna, 19ª ed. Cap. 360, p. 2004.
- Lee WM, Dienstag JL: Hepatitis por sustancias tóxicas y fármacos. Harrison, Principios de medicina interna, 19ª ed. Cap 361, p. 2023.
- O`Grady JG. Acute liver failure. Postgrad Med J, 2005; 81: 148-54.
- Polson J, Lee W.M.. AASLD Position Paper: The management of acute liver failure. Hepatology, 2005; May: 1179-1197.